Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)

Cours du Pr Tahmi — « ESC 2024 »

À RETENIR

- ESC 2019 : probabilité pré-test (PTP) selon l'âge, le sexe et le type de symptôme (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée).
- PTP la plus élevée : homme ≥ 70 ans avec angor typique = **52 %**.
- ESC 2019 : PTP **< 5 %** → pas d'examen ; **5–15 %** → tests non invasifs envisagés selon la probabilité clinique ; **> 15 %** → tests non invasifs +++ (**> 85 %** → coronarographie).
- ↑ probabilité : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, troubles de repolarisation), dysfonction systolique VG, score d'Agatston **> 400**.
- ↓ probabilité : ECG d'effort négatif, score calcique = 0.
- ESC 2024 : douleur thoracique **0–3 pts**, dyspnée **0–2 pts**, nombre de FDR, âge, sexe.
- ESC 2024 : très faible **< 5 %** → aucun examen ; faible **5–15 %** → score calcique ; intermédiaire **15–50 %** → score calcique / imagerie fonctionnelle ; haut **50–85 %** → imagerie fonctionnelle ; très haut **> 85 %** → coronarographie.

I. ESC 2019

1. Tableau de probabilité pré-test (%)

Âge (ans)	Angor typique		Angor atypique		Douleur non angineuse		Dyspnée	
	H	F	H	F	H	F	H	F
30–39	3	5	4	3	1	1	0	3
40–49	22	10	10	6	3	2	12	3
50–59	32	13	17	6	11	3	20	9
60–69	44	16	26	11	22	6	27	14
≥ 70	52	27	34	19	24	10	32	12

Dans les notes, les cases sont surlignées par classe de probabilité : jaune (≤ 5 %), vert (5–15 %), rose (> 15 %).

2. Conduite à tenir

- PTP **< 5 %** (faible risque) ⇒ pas d'examens complémentaires.
- PTP intermédiaire **5–15 %** ⇒ tests diagnostiques non invasifs envisagés après avoir évalué la probabilité clinique (pondérée par les FDR CV).
- PTP **> 15 %** (haut risque) ⇒ tests non invasifs +++ (**> 85 %** → coronarographie).

3. Facteurs modifiant la probabilité clinique

↑ Probabilité	↓ Probabilité
• FDR : dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, antécédents familiaux. • ECG de repos : onde Q, troubles de la repolarisation. • Dysfonction systolique du VG. • Calcifications au scanner : score d'Agatston **> 400**.	• ECG d'effort négatif. • Score calcique = 0.

II. ESC 2024

1. Éléments du calcul

- Douleur thoracique : **0 à 3 points** ; dyspnée : **0 à 2 points**.
- Nombre de FDR : antécédents familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète.
- Âge, sexe.

2. Catégories et conduite à tenir

Catégorie	Probabilité	Conduite (page de cours)	Conduite (fiche récapitulative)
Très faible risque (TFR)	**< 5 %**	Aucun examen	Rien
Faible risque (FR)	**5–15 %**	Score calcique	Clinique ± coroscanner
Risque intermédiaire (RI)	**15–50 %**	Score calcique ; imagerie fonctionnelle : TSM, écho de stress, IRM	Coroscanner ; examen fonctionnel
Haut risque (HR)	**50–85 %**	Imagerie fonctionnelle	Examen fonctionnel
Très haut risque (THR)	**> 85 %**	Coronarographie	Coronarographie

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. PTP (ESC 2019) d'un homme de 60–69 ans avec angor typique ?	44 %.
2. PTP (ESC 2019) d'une femme de 40–49 ans avec angor typique ?	10 %.
3. Conduite ESC 2019 si PTP > 15 % ?	Tests non invasifs +++ ; > 85 % → coronarographie.
4. Quels éléments augmentent la probabilité clinique ?	FDR CV, onde Q / troubles de repolarisation, dysfonction VG, score d'Agatston > 400.
5. Quels éléments la diminuent ?	ECG d'effort négatif, score calcique nul.
6. Points attribués à la douleur thoracique et à la dyspnée (ESC 2024) ?	0–3 points ; 0–2 points.
7. Bornes des catégories ESC 2024 ?	< 5 % ; 5–15 % ; 15–50 % ; 50–85 % ; > 85 %.